

Установка надлобкового катетера

WARWIKI

Информация для пациента · Что ожидать перед процедурой

Надлобковый катетер (SPT) — мягкая трубка, отводящая мочу из мочевого пузыря через небольшое отверстие в нижней части живота, чуть выше лобковой кости, в обход уретры. В этом листке объясняется, зачем его устанавливают, как подготовиться и чего ожидать.

Об этой процедуре

Мочевой пузырь накапливает мочу. Когда отток привычным путём невозможен или уретру нужно разгрузить, катетер вводят прямо в мочевой пузырь через переднюю брюшную стенку. Поскольку уретра не задействована, надлобковый катетер удобнее при длительном дренировании и менее травматичен.

Ваш врач может рекомендовать надлобковый катетер, чтобы:

- Дренировать мочевой пузырь при невозможности самостоятельного мочеиспускания
- Разгрузить или защитить уретру после операции или травмы
- Обеспечить комфортный длительный отток мочи (например, при нейрогенном мочевом пузыре)
- Избежать раздражения, которое вызывает уретральный катетер при длительном использовании
- Сохранить нормальную половую жизнь и проводить “пробы мочеиспускания” (катетер перекрывают, чтобы проверить функцию)

Это безопасно?

Да. Это рутинная, как правило безопасная процедура. Для защиты кишечника мочевой пузырь наполняют, чтобы он прилегал к брюшной стенке; ориентируются по УЗИ и/или миниатюрной камере. Большинство осложнений — незначительное кровотечение, дискомфорт или спазмы — проходят быстро. Сообщите врачу о перенесённых операциях на животе или в области малого таза.

ТЕРМИНЫ

Надлобковый

Выше лобковой кости, в нижней части живота — место выхода катетера.

Мочевой пузырь

Орган, накапливающий мочу до её выделения.

Катетер

Мягкая трубка для отведения мочи. Надлобковый катетер проходит через живот, а не через уретру.

Уретра

Канал, по которому моча выводится из организма. Надлобковый катетер обходит его.

Местная анестезия

Обезболивающее, вводимое в кожу: место процедуры не болит.

Седация / анестезия

Препараты для расслабления или погружения в сон (общая анестезия) во время процедуры.

УЗИ / камера

Инструменты контроля — ультразвук или миниатюрная камера в мочевом пузыре — для точного введения катетера.

Спазм мочевого пузыря

Внезапная судорожная боль — частое явление после процедуры, поддаётся лечению.

БУДЕТ ЛИ БОЛЬНО? Это зависит от метода: иногда местное обезболивание с седацией, многие вмешательства — под **общей или спинальной анестезией**. Сама процедура занимает около 15–30 минут.

Как подготовиться (До процедуры)

- **Придите с полным мочевым пузырьём, если попросят** — это повышает безопасность. Врач может попросить вас выпить воды и не мочиться, либо наполнит пузырь самостоятельно.
- **Соблюдайте предписания о голодании** — если планируется седация или общая анестезия, нельзя есть и пить несколько часов до процедуры.
- **Организируйте сопровождение домой**, если вам будет введена седация.

Заранее сообщите врачу, если вы:

- Перенесли **операцию на животе или в малом тазу** — рубцовая ткань может изменить оптимальный доступ
- Принимаете **антикоагулянты** или имеете нарушения свёртываемости — препараты часто отменяют перед вмешательством
- Возможно **беременны**, есть инфекция или аллергия на анестетики / латекс

Что происходит во время процедуры

- 1 Вас укладывают в нужное положение и вводят анестезию — местную с седацией либо общую или спинальную. Нижнюю часть живота обрабатывают антисептиком.
- 2 Мочевой пузырь наполняют жидкостью (если он ещё не полон), чтобы он прижался к брюшной стенке и отошёл от кишечника.
- 3 Под контролем УЗИ и/или камеры врач делает небольшой прокол чуть выше лобковой кости и вводит катетер в мочевой пузырь.
- 4 Внутри пузыря раздувают маленький баллон, фиксирующий катетер; его подключают к дренажному мешку.

После процедуры

- Моча отводится в мешок; перед выпиской вам **объяснят уход за катетером и кожей вокруг него**.
- Умеренная болезненность, спазмы мочевого пузыря или **небольшая примесь крови в моче** в первые один-два дня — норма.
- **Первую замену катетера выполняет врач** примерно через 4–6 недель. Если катетер выпал, немедленно свяжитесь с командой — канал может закрыться в течение нескольких часов.

Обратитесь к врачу, если у вас:

- Повышение температуры или озноб
- Катетер **выпал** или перестал дренировать (моча не поступает в мешок)
- Нарастающая боль в животе, отёк или сильное кровотечение
- Мутная моча с неприятным запахом (признак инфекции)

ТРИ ВАЖНЫХ МОМЕНТА

1. Надлобковый катетер дренирует мочевой пузырь через небольшое отверстие в нижней части живота, минуя уретру — это удобнее при длительном использовании.
2. Подготовка: полный мочевой пузырь (если попросят), голодание, сопровождение при седации; сообщите о перенесённых операциях, антикоагулянтах или беременности.
3. Процедуру выполняют под местной анестезией с седацией или под общей. Врач обучит уходу за катетером; первую замену проводят через 4–6 недель.